

Информационный отчёт

05.10.2026, 03:00:00

Поддержка принятия решений. Нема не устанавливает диагноз и не назначает лечение. Результат требует оценки врачом.

ДЕМОНСТРАЦИЯ. Вымышленные анализы. Показан сохранённый расчёт локальной модели и рекомендации для выбранной роли.

Оценка по гемоглобину

Гемоглобин ниже порога анемии.

Hb: 95 г/л. Порог: 120 г/л. Отсутствие анемии по Hb не исключает дефициты.

Предполагаемое состояние

Возможная B12-дефицитная анемия

Модель допускает: Витамин B12

Что удалось оценить

Гемоглобин ниже порога.

Полнота данных

Указано 35 из 35 лабораторных показателей; доступны базовый контекст ОАК и часть анализов на дефициты. Это не гарантирует точность вывода.

Следующие шаги

- Обсудите с врачом результаты B12, симптомы и принимаемые добавки. Рекомендуется оценить общий B12 (приоритетно; активный B12 — альтернатива), фолаты, креатинин, eGFR, ферритин, TSAT, CRP и ретикулоциты; MMA — по необходимости. Сверьтесь с уже имеющимися результатами и обсудите сдачу недостающих анализов.
- Ферритин и показатель воспаления уже добавлены. Обсудите их вместе с врачом: воспаление может влиять на ферритин. Для уточнения картины рекомендуется оценить ретикулоциты, RDW, sTfR и TSAT; при необходимости — обсудить сдачу недостающих анализов.

3. Результаты B12 и фолатов уже добавлены. Передайте врачу оба бланка и сведения о добавках, чтобы обсуждать их вместе.

4. Сохраните бланки и даты исследований для обсуждения с врачом. Какие анализы повторять и когда, зависит от вашей ситуации.

Ограничения оценки

Полностью вымышленные анализы. Сохранён настоящий расчёт локальной исследовательской модели; это пример работы программы, а не данные пациента.

Модели исследовательские, scores не откалиброваны. Отсутствие анализа не считается нормой.

Оценки модели 0–1 не являются проверенной вероятностью заболевания. Низкие значения не исключают дефицит.

Часть текстов уточнена медицинской командой. Каталоги и правила достаточности остаются черновиком; клиническая валидация не выполнена.

Исходные показатели

Возраст: 65. Пол: женский. Пустой показатель не считается нормальным.

Гемоглобин: 95 г/л

Эритроциты: $2.4 \times 10^{12}/л$

Объём эритроцита: 112 фл

Гемоглобин в эритроците: 39 пг

Гематокрит: 28 %

Распределение эритроцитов: 21 %

Ферритин: 65 мкг/л

Сывороточное железо: 16 мкмоль/л

Витамин B₁₂: 60 пг/мл

Фолаты: 10 нг/мл

Концентрация Hb: 335 г/л

Тромбоциты: $250 \times 10^9/л$

Лейкоциты: $6 \times 10^9/л$

Ретикулоциты: 0.5 %

Трансферрин: 2.5 г/л

ОЖСС: 63 мкмоль/л

НЖСС: 47 мкмоль/л

Насыщение трансферрина: 25 %

Растворимый рецептор трансферрина: 1.5 мг/л
Hb ретикулоцитов: 31 пг
Активный В₁₂: 8 пмоль/л
Метилмалоновая кислота: 2 мкмоль/л
Гомоцистеин: 45 мкмоль/л
Витамин В₆: 45 нмоль/л
Медь: 17 мкмоль/л
Церулоплазмин: 0.25 г/л
С-реактивный белок: 1 мг/л
СОЭ: 8 мм/ч
Креатинин: 70 мкмоль/л
СКФ: 100 мл/мин/1,73 м²
ТТГ: 2 мМЕ/л
Альбумин: 43 г/л
ЛДГ: 550 Ед/л
Непрямой билирубин: 22 мкмоль/л
Гаптоглобин: 1.2 г/л

Происхождение отчёта

Модель: hema-baseline-v1-b413ce1e45d6. Пример: В12: анемия и расширенная панель.
Версия файла фраз: phrases-draft-1.2. ID отчёта: локальный.